

一、疾病理解與病理機轉

高血壓是指血液對血管壁的壓力長期過高,就像水管裡的水壓太大一樣,會讓血管承受過多壓力。心臟收縮時產生的壓力叫收縮壓,舒張時叫舒張壓,當這兩個數值長期超過130/80 mmHg時就是高血壓。這種情況初期通常沒有明顯感覺,但會慢慢傷害血管,增加中風、心臟病、腎臟病的風險,所以被稱為『沉靜殺手』。高血壓可能因為飲食太鹹太油、體重過重、喝酒過量、抽菸、壓力大、家族遺傳或年紀增長而引起。

二、藥物知識與服藥遵從

1. 請務必按照醫師指示的時間和劑量服藥,不要自行調整或停藥。
2. 了解每種藥物的作用,有些是幫助血管放鬆,有些是減少體內水分來降低血壓。
3. 如果服藥後出現頭暈、嗜睡等不適,應立即告知醫護人員。
4. 過去有藥物過敏或效果不佳的情況,要主動告訴醫師。
5. 服用降血壓藥物後,下床前先坐一會兒,避免因頭暈而跌倒。
6. 記錄長期用藥記錄卡,就醫時帶給醫師參考。

三、警訊辨識與處置行為

1. 如果出現劇烈頭痛、頭暈、視力模糊、呼吸急促等症狀,可能是血壓失控的警訊。
2. 測量血壓時發現數值異常升高(收縮壓180或舒張壓110),應立即就醫。
3. 出現胸悶、心悸、無法平躺呼吸時,可能是心臟負擔過重的表現。
4. 一日體重突然增加1公斤或一周增加2公斤以上,可能是水腫加劇。
5. 發現下肢水腫加重、腹脹噁心、食慾不振時應返院檢查。
6. 如有暈厥、意識改變等嚴重症狀,必須立即急診。

四、飲食與活動建議

1. 每日鹽分限制在2-4公克,避免醃製食品和加工食物。
2. 採用DASH飲食,多吃蔬菜水果、全穀類、低脂乳製品和堅果。
3. 男性每周飲酒少於100克,女性少於50克,最好戒酒。
4. 維持理想體重(BMI 20-24.9),過重時應減重。
5. 每周運動5-7天,每次至少30分鐘有氧運動如快走、游泳。
6. 絕對戒菸,包括傳統香菸和電子煙。
7. 避免攝取含咖啡因飲料及辛辣刺激食物。
8. 注意氣溫變化,避免突然的冷熱刺激如三溫暖。

五、出院追蹤與門診照護導引

1. 定期回門診追蹤血壓控制情況,通常1~3個月一次。
2. 每日早晚各測量血壓一次,每次量2次取平均值,連續7天記錄供醫師判讀。
3. 測量血壓前休息5分鐘,坐姿正確(背有靠、腳平放),手臂與心臟同高。

4. 記錄血壓、脈搏、體重每日變化,回診時帶給醫師參考。
5. 穩定情緒、適度休息,避免過度壓力影響血壓。
6. 如有任何不適或疑問,可撥打諮詢電話(02)2737-2181分機8490。

六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

■ 心臟衰竭(ICD-10: I509)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日測量體重,若一天增加 1 公斤或一週增加 2 公斤以上,需立即聯繫醫療團隊。
- 限制液體攝取(依醫師指示)及鹽分(每日 < 2 公克),戒菸限酒。
- 出現呼吸困難加重、無法平躺、下肢水腫加劇時,需緊急就醫。

■ 冠狀動脈疾病(ICD-10: I2510)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 隨身攜帶舌下硝酸甘油,胸痛發作時立即含服;若5分鐘未緩解可再含一片,仍無效需緊急就醫。
- 按時服用抗血小板藥物(如阿斯匹靈、Clopidogrel),不可自行停藥。
- 控制高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子;採低鹽低脂飲食,每週規律有氧運動3次以上。

■ 第二型糖尿病(ICD-10: E118)

- 目前用藥中可能包含降血糖藥或胰島素,請規律監測血糖,並留意冒冷汗、手抖、心悸等低血糖症狀。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 依醫師指示定時測量血糖,餐前目標 80~130 mg/dL,餐後2小時目標 < 160 mg/dL。
- 詳細記錄每次血糖值(日期、時間、餐前/後、藥物劑量),回診時提供醫師調整劑量。
- 每日檢查雙腳皮膚,選擇棉質吸汗襪與寬頭透氣鞋,避免赤腳或穿夾腳拖。

■ 高血壓(ICD-10: I10)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日早晚各量一次血壓,遵循 722 原則(7天、每日早晚各1次、每次量2遍),記錄後回診時提供醫師參考。
- 每日鹽分攝取限制在 2~4 公克,採用 DASH 飲食(多蔬果、全穀、低脂)。
- 規律服用降壓藥,不可自行停藥或減量;戒菸、限酒、維持 BMI 20~25。

■ 高血脂症(ICD-10: E785)

- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

■ 心律不整(ICD-10: I480)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 避免菸、酒、濃茶、咖啡等刺激性物質,這些可能誘發心律不整。
- 出現持續心悸、胸悶、頭暈、昏厥時,應立即就醫並記錄發作時間與症狀。
- 抗心律不整藥物不可自行調整劑量或停藥,定期回心臟科門診追蹤心電圖。

■ 逆流性食道炎(ICD-10: K219)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 飯後不立即平躺,睡前2小時避免進食;抬高床頭約15公分可減少夜間逆流。
- 避免油膩、辛辣、巧克力、咖啡、酒精等刺激性食物。
- 按醫師指示服用制酸劑或質子幫浦抑制劑,即使症狀消失也需依醫囑完成療程。

七、參考衛教手冊

1. 高血壓
2. 低磷飲食
3. 上腸胃道出血
4. 心衰竭
5. 冠狀動脈粥樣硬化心臟病(冠心病)
6. 糖尿病足部病變護理指導
7. 住院病人就醫安全守則
8. 血糖自我監測衛教指導
9. 準備低鉀飲食
10. 高血脂症護理指導
11. 心臟節律不整
12. 逆流性食道炎護理指導

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31